

Médecine tropicale L2 S4 — QCM

Bothriocéphalose se traite avec la /le(s) molécule(s) suivantes :

Niclosamide

Metronidazole

Pentamidine

Rifampicine

Le signe clinique majeur de l'oxyurose est :

Diarrhée avec déshydratation

Pincement des ailes du nez

Prurit anal vespéral

Des troubles intestinaux

Dans l'atteinte osseuse par le pian la lésion dite Goundou traduit :

Atteinte du tibia

Atteinte des doigts

Hypertrophie de l'os propre du nez

Le syndrome de Loëffler s'observe

Au cours de l'ascaridiose

Au cours de l'anguillulose

Au cours de la trichocéphalose

Au cours anisakidose

L'agent pathogène de l'onchocercose est :

Similiumdamnosum

Onchocerca volvulus

La nymphe

La mouche tsé-tsé

Dans la trypanosomiase humaine africaine, l'inversion du rythme nycthéméral (trouble du sommeil) survient :

A la phase méningo-encéphalitique

A la phase lymphatico-sanguine

L'association artesunate (10 mg / kg / jour + amodiaquine 4 mg/ kg/jour) est utilisé dans le traitement de paludisme simple selon les directives nationales

A-VRAI B-FAUX

Dans la giardiose la charge virale (dose minimale infectante) est comprise entre :

10 et 100 kystes

5 et 9 kystes

1 et 4 kyste

La cible de la bilharziose à schistosoma mansoni est

Le foie

Le rectum

La langue

Les facteurs déclenchants de l'anguillulose maligne

La corticothérapie

Le VIH-SIDA

L'infection à HTLV1

La larve strongyloïde infestante

Les parasites suivants sont des nématodes

Entamoeba Histolica

Giardia intestinalis

Entérobias Vermicularis

Ankylostoma duodénale.

La transmission de l'ankylostomose se fait par :

Voie transcutanée

Voie digestive

Voie Sexuelle

La localisation pulmonaire de l'ascaris se traduit par :

Le syndrome de Loëffler

Une hémoptysie

Le syndrome dyspeptique

Il existe encore des cas de dracunculose en côte d'ivoire

VRAI B-FAUX

Dans le paludisme grave on note une parasitémie positive à plasmodium falciparum avec :

Nausée

Une acidose métabolique

Un œdème pulmonaire

Un prurit.

Un patient atteint d'oxyurose peut présenter les complications suivantes :

Salpingite

Eczéma

Prurit anal vespéral

Infection urinaire à colibacilles

La transmission de la giardiose est féco-orale

VRAI B-FAUX

L'amibiase est une maladie strictement humaine

VRAI B-FAUX

La bilharziose à schistosoma haematobium

Se manifeste par une hématurie

Se manifeste par une hématurie macroscopique

Est évitable par la vaccination

Se traite avec le praziquantel

Dans la forme majeure de la Trichocéphalose, on note :

Un syndrome dyspeptique

Une appendicite

Recto-colite

La transmission du pian est soit congénitale soit vénérienne

VRAI B-FAUX

L'amibiase dans sa localisation extra colique peut atteindre par voie sanguine :

Les reins

Le cerveau

Le pancréas

La rate

La lésion dite GANGOZA dans le pian survient à la phase tertiaire de la maladie

VRAI B-FAUX

Dans le traitement de première intention du pian, là ou lesquelles (s) des molécules suivantes est (sont) utilisé (es) ?

Azithromycine

Doxycycline 200 mg

Metronidazole 500 mg

La localisation préférentielle de la dracunculose est

Les membres inférieurs

Les oreilles

La main

La trichocéphalose sévit plus chez :

Chez les adultes femmes

Chez les nouveaux nés

Chez les adultes hommes et femmes

Chez les enfants de 2 à 7 ans

La giardiase :

Se traite avec les 5-nitro-imidazolés

Est une nématodose

Sévit majoritairement dans les collectivités d'enfants

Est diagnostiqués avec le scanner

La prévention du pian se fait par la vaccination

VRAI B-FAUX

La forme d'Entamoeba Histolica à l'origine de dissémination de l'amibiase est :

La forme kystique

La forme végétative

La forme larvaire

Le chancre pianique est une ulcération prurigineuse, crouteuse, reposant sur une base indurée

VRAI B-FAUX

L'anguillulose commune

Se traite avec l'ivermectine

Peut se contracter par voie sexuelle

Est une cestodose

Est évitable par la vaccination

Les parasitoses suivantes se contractent par voie transcutanée :

Anguillulose

Dracunculose

Ankylostomose

Trichinose

L'Anguillulose maligne :

Se traite avec l'association antibiotique + antiparasitaire

Est une cestodose

Est confirmée par la mise en évidence de larves strongyloides à l'examen parasitologique des selles.

Se confirme par une numération formule sanguine (NFS)

Les parasitoses suivantes sont provoquées par l'ingestion de viande de porc mal cuite (KOFFI DAMOI) dit El Hadj :

La trichinose

Le tænia à diphyllobothriumlatum

L'anisakidose

Le taeniasolium

Selon les directives de prise en charge du paludisme grave en vigueur en côte d'ivoire, un enfant de 10 kg doit recevoir au premier jour du traitement une dose d'artesunate injectable à raison de :

24 mg à H0 H6 et H24

2, 4 mg à H0, H12 et H 24

24 mg à H0 H 18 et H24

24 mg à H0, H12 et H24

L'association artesunate +amodiaquine est efficace dans le traitement :

La fièvre jaune

De la dengue

Du paludisme simple

Les pathologies suivantes sont des nématodoses

La trichinose

La dracunculose

L'anisakidose

La taeniasose à taeniasaginata

L'agent pathogène de la syphilis vénérienne est :

Treponéma pallidum

Treponéma pertenue

Ankylostoma duodénale

Trichinella spiralis

Le protocole de traitement de la syphilis tertiaire chez un adulte est :

Extencilline 2,4 M. UI ; une injection de 2,4M UI/ semaine pendant 03 à 04 semaines

Métronidazole comprimés 500 mg : 2 comprimés 2 fois par jour pendant 7 jours

Praziquantel cp : 2 comprimés en prise unique

Bothriocéphalose entraîne une :

Une anémie microcytaire

Une anémie macrocytaire et mégaloblastique

Prurit intense